

女性不妊症の 系統診断と治療

1

「不妊」

生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、
避妊することなく通常の性交を継続的に行っている
にもかかわらず、妊娠の成立をみない状態。

「産婦人科用語集・用語解説集 改訂第4版」 (日本産科婦人科学会編)

「不妊症」

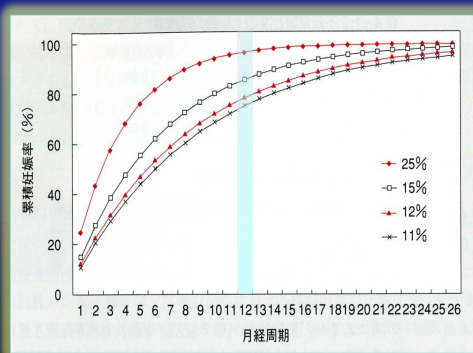
不妊の状態で、挙児を希望し医学的治療を
必要とする場合。全夫婦の約10～15%。

* 一定期間

1. 日本産科婦人科学会 : 1年間
2. 世界保健機関 (WHO) : 1年間
3. 米国生殖医学会 : 1年間
4. 欧州ヒト生殖医学会 : 1年間

2

1周期あたりの妊娠率と累積妊娠率



周期あたりの妊娠率 **25%**

||
1年間の累積妊娠率>90%

周期あたりの妊娠率 **15%**

||
1年間の累積妊娠率>80%

3

1年間での妊娠期待度

- 20～24歳: 86%
- 25～29歳: 78%
- 30～34歳: 63%
- 35～39歳: 52%

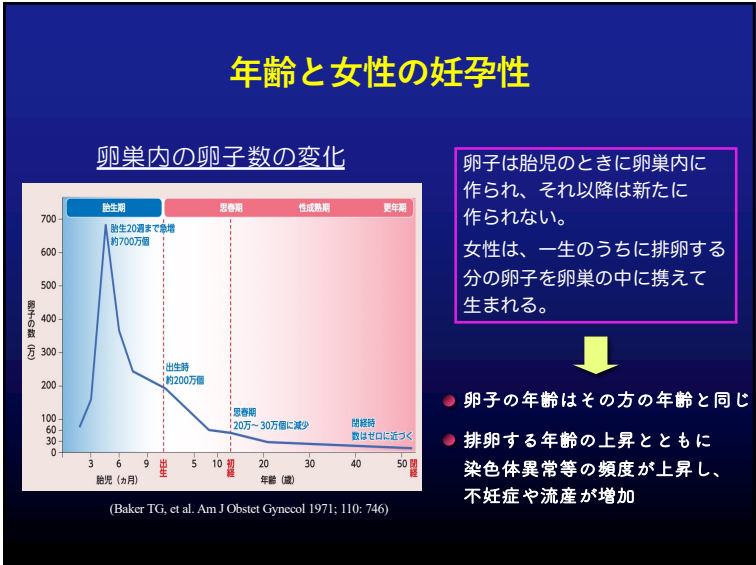
不妊症の頻度: 10～15%

- 20～24歳: 5%
- 25～29歳: 9%
- 30～34歳: 15%
- 35～39歳: 30%
- 40～44歳: 64%

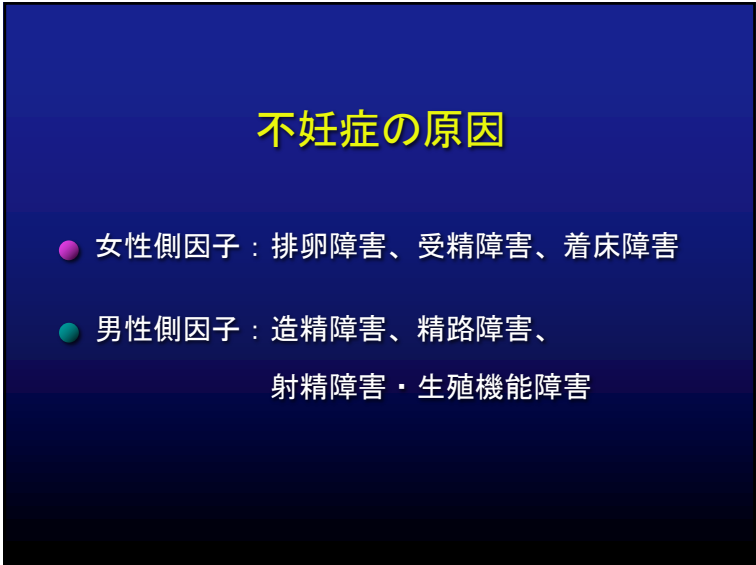
(Menken J. Science 1986)

年齢が若いうちに妊娠を試みるのが望ましい
不妊治療についても同様である

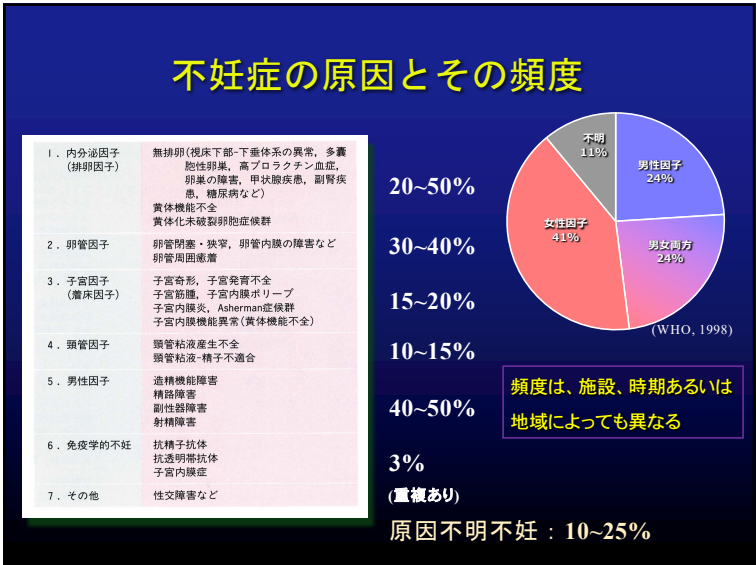
4



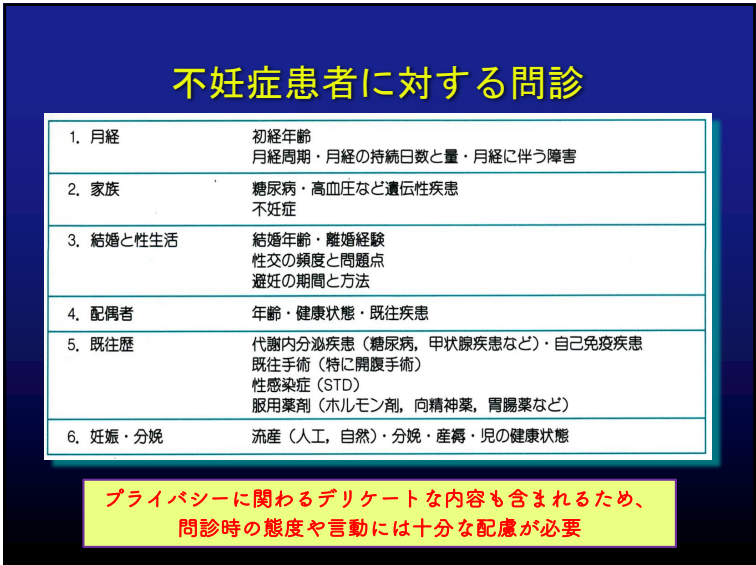
5



6



7



8

不妊症の一般検査（スクリーニング検査）とそれによって診断できる原因疾患

スクリーニング検査	不妊因子	原因疾患	二次検査
・基礎体温 ・ホルモン検査 - 卵胞期：LH, FSH, PRL, E ₂ , T - 黄体期：E ₂ , Prog. ・子宮内膜日付診	内分泌、排卵因子	・視床下部-下垂体系の異常 ・高プロラクチン血症 ・黄体機能不全 ・多嚕卵性卵巣症候群 (PCOS) ・早発卵巣機能不全 (POF) ・全身疾患 (甲状腺疾患、糖尿病、自閉症)	・ホルモン検査 - GnRH, TRH 負荷試験 ・染色体検査 ・腹腔鏡検査 - 卵巣生検 ・自己抗体検査 ・経陰超音波検査 - 卵胞径、子宮内膜観察
・卵管通気法 ・子宮卵管造影	卵管因子	・卵管透過障害 ・卵管閉塞 ・内臓症	・腹腔鏡検査 ・卵管鏡検査
・経陰超音波検査 ・子宮卵管造影	子宮因子	・子宮頸管 ・子宮内膜ポリープ ・子宮腺筋症 ・子宮畸形 ・アッシャーマン症候群	MRI, CT 子宮鏡検査 腹腔鏡検査
・経陰超音波検査 ・頸管粘液検査 ・性交後試験 (Huhner テスト)	頸管因子	・頸管粘液産生不全 ・抗精子抗体	・染色体検査 ・卵巣生検 ・Hypoosmotic swelling テスト ・ハムスター試験 ・Penetrak テスト ・Acro beads テスト
・精液検査	男性因子	・造精機能の障害 ・精子輸送路の障害 ・副性腺の障害 ・機能的性不全 ・精子の形態異常	
・性交後試験 (Huhner テスト)	免疫因子	・抗精子抗体 ・抗透明帯抗体 ・子宮内抗体	精子不動化試験

不妊症の一般検査
検査の月経周期での施行時期

BBT

低温期	排卵期	高温期
卵管疎通性検査 ホルモン検査 (FSH, LH, E ₂ , T) GnRH test	頸管粘液検査 性交後検査	黄体機能検査 ホルモン検査 (E ₂ , P, PRL) 子宮内膜日付診

その他の検査
クラミジア抗体検査 抗精子抗体
超音波検査

不妊症の一般検査

1. 基礎体温

<測定法>
覚醒時直ちに婦人体温計を用いて口腔内（舌下）で計測

<評価>

1. 排卵の有無
 - ・排卵 (+) ⇨ 二相性 (低温相と高温相の差 $\geq 0.3^{\circ}\text{C}$)
2. 排卵日の推測
3. 黄体機能の評価
 - ・黄体機能不全 ⇨ 高温相持続期間 ≤ 10 日間
低温相と高温相の差 $< 0.3^{\circ}\text{C}$

不妊症の一般検査

1. 基礎体温

基礎体温と排卵日

項目	割合
体温陥落日(dip)	56.3%
最低体温日(nadir)	51.8%
低温最長日(coverline)	62.5%
高温相初日(first day of BBT rise)	26.8%

不妊症の一般検査

1. 基礎体温

＜評価における留意点＞

- 低温相と高温相の差が 0.3°C 以下の場合、また高温相が7日未満の場合は二相性でも無排卵のことがある。
- 一相性でも約3.4%に排卵が認められる。
- 黄体化非破裂卵胞の診断ができない。
(超音波検査との組み合わせにより診断)
- 排卵日の特定はできない。
- 高温相が正常でもプロゲステロン分泌が少ない黄体機能不全が存在する。

13

不妊症の一般検査

2. 血中ホルモン検査

＜目的＞

視床下部-下垂体-卵巢系の機能評価

＜検査項目＞

1. LH、FSH
2. エストロゲン、プロゲステロン
3. テストステロン
4. プロラクチン
5. 抗ミューラー管ホルモン

月経周期とホルモン値

	エストラジオール E ₂ (pg/ml)	プロゲステロン P (ng/ml)	LH (mIU/ml)	FSH (mIU/ml)	PRL (ng/ml)	テストステロン T (ng/ml)
卵胞期	20~40	0.1~0.5	5~20	5~15	<15	0.2~0.6
排卵期	150~400	0.1~0.5	40~100	10~20	<15	0.2~0.6
黄体期	100~300	5.0~20.0	5~20	5~15	<15	0.2~0.6

14

不妊症の一般検査

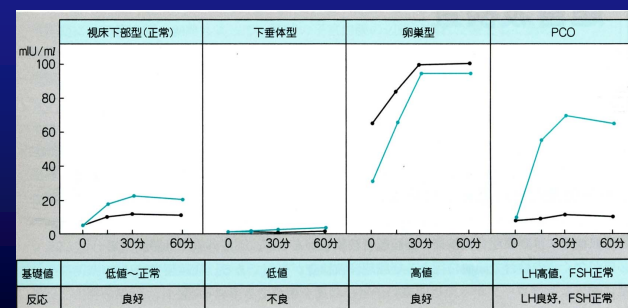
2. 血中ホルモン検査

抗ミューラー管ホルモン
(anti-Mullerian hormone; AMH)

- 一次卵胞から小胞状卵胞までの顆粒膜細胞から分泌される
- 卵胞数を反映しており、卵巢予備能の検査として有用である
- 月経周期の影響を受けないため、測定時期の制限がない
- 年齢に依存し、閉経すれば測定感度以下となる
- 多嚢胞性卵巢症候群では高い傾向があり、早発卵巢不全などでは極端に低下している
- 1.0ng/ml未満の場合を、卵巢予備能低下とすることが多い

15

GnRH負荷試験



16

不妊症の一般検査

3. 卵管疎通性検査

- 卵管通気法 (Rubin test)
- 子宮卵管造影法 (hysterosalpingography; HSG)
- 卵管通水法

17

不妊症の一般検査

卵管通気法 (Rubin test)

<方法>

外子宮口から気体（通常炭酸ガス）を自動注入装置を用いて一定の圧力・速度で注入し、子宮内圧の変化をキモグラフで描いて、その曲線の形態から卵管の疎通性を判定する。

- 低温相に施行
- 聴診器で腹腔内への気体の流出音を聴取
- 検査終了後起立させ、肩甲骨の有無を確認

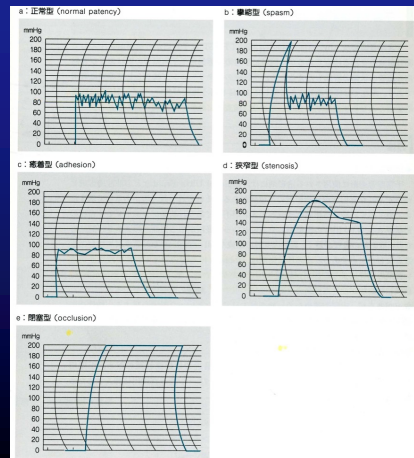
18

不妊症の一般検査

卵管通気法

結果の判定

- 正常型
- 攣縮型
- 癒着型
- 狭窄型
- 閉塞型



19

不妊症の一般検査

子宮卵管造影法 (HSG)

<方法>

外子宮口から造影剤を注入し卵管の疎通性をみる。

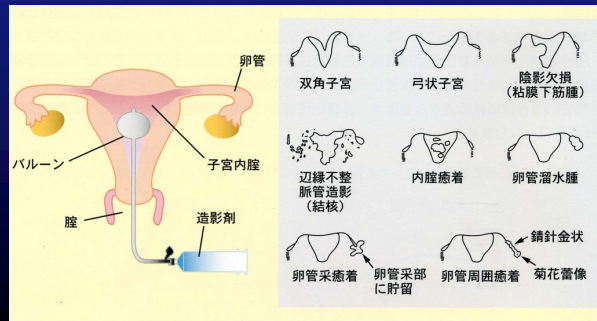
- 低温相に施行
- 子宮の形態異常や子宮頸管の形状および骨盤内の癒着の状態の評価も行える
- 卵管疎通性における治療効果を有しており、検査後に妊娠率の増加が認められる。

20

不妊症の一般検査

子宮卵管造影法 (HSG)

方法と典型的所見

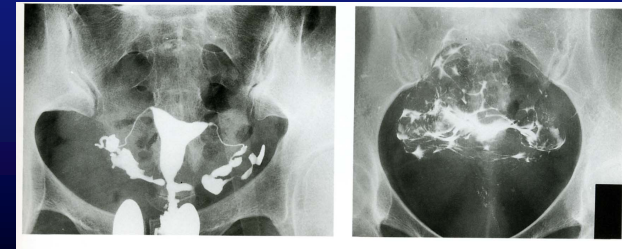


21

不妊症の一般検査

子宮卵管造影法 (HSG) 結果例

正常例



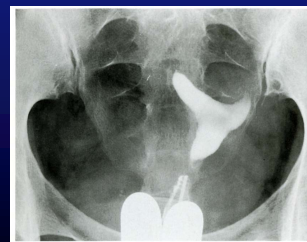
22

不妊症の一般検査

子宮卵管造影法 (HSG) 結果例

卵管采周囲癒着

卵管間質部閉塞



23

不妊症の一般検査

子宮卵管造影法 (HSG) 結果例

卵管水腫

外傷性子宮腔癒着



24

不妊症の一般検査

子宮卵管造影法 (HSG) 結果例

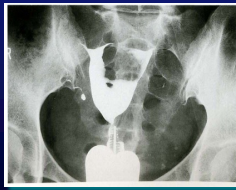
単角子宮



双角子宮



粘膜下筋腫



25

不妊症の一般検査

卵管通水法

<方法>

経腔超音波下に子宮腔内に生理食塩水を注入し、
ダグラス窩に腹水が貯留することで卵管の疎通性を確認

- 低温相に施行
- 片側以上の卵管に疎通性があるという情報が得られない

26

不妊症の一般検査

4. 子宮頸管粘液検査

子宮頸管粘液は月経周期により分泌量、性状に変化がみられる

- 排卵期の頸管粘液 (血中エストロゲン上昇による)
 - ▶ 分泌量 $\geq 0.3\text{ml}$
 - ▶ 水様透明
 - ▶ 粘稠性低下、牽糸性 $\geq 10\text{cm}$
 - ▶ 乾燥させた際に羊歯状結晶形成

27

不妊症の一般検査

5. 性交後検査 (Huhner test)

精子と頸管粘液の適合性を評価する。

<方法>

排卵時期に性交し、その2~10(~24)時間後に採取した
頸管粘液中の精子数と運動率を測定する

<正常>

総精子数：10~20以上/HPF

運動率：50%以上

(高速での直線運動をするものが1個以上)

28

不妊症の一般検査

5. 性交後検査 (Huhner test)

性交後試験陰性の原因

女性側因子

1. 検査のタイミング
2. 排卵障害
3. 性交障害：性交痛等
4. 解剖学的異常：
子宮筋腫、子宮頸管ポリープ等
5. 頸管粘液不良
6. 抗精子抗体

男性側因子

1. 精液所見不良
2. 性交障害：勃起障害、逆行性射精等
3. 抗精子抗体

29

不妊症の一般検査

6. 子宮内膜日付診

＜方法＞

高温相中期(6~7日目)に子宮内膜を採取し、
得られた内膜が組織学的に月経周期の何日目に
相当するかを診断する

＜評価＞

実際の月経周期の日付と組織学的な日付診のずれが
3日以上ある場合、黄体機能不全として治療

30

不妊症の一般検査

7. クラミジア抗体検査

クラミジア頸管炎、卵管炎は腹腔内の
癒着を引き起こし不妊症の原因となりうる

- 子宮卵管造影等子宮内操作を行う検査により
子宮内、腹腔内へ感染を広げる恐れもあるため
不妊検査の最初に行うことが望ましい

31

不妊症の一般検査

8. 抗精子抗体

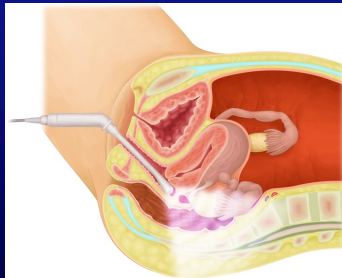
- 男性、女性ともに検出される。
- 男性の場合は射出精子にすでに結合した抗体により、女性の場合は
頸管粘液、子宮・卵管分泌液、卵胞液などに移行した抗体が精子に
結合して、精子の女性生殖器管内での移動あるいは受精過程での
精子受精能、あるいは精子の卵透明帯への結合が障害されて不妊の
原因となる。
- 抗体価が高い場合には、自然妊娠は困難で、人工授精、または
体外受精・胚移植治療の適応となる。

32

不妊症の一般検査

9. 経膈超音波断層法

- 月経周期の時期による子宮内膜、卵胞の変化の観察
- 子宮、卵巣の基質性疾患の検索



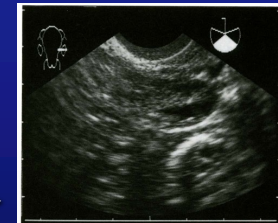
33

不妊症の一般検査

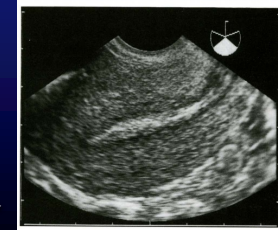
9. 経膈超音波断層法

月経期

<卵巣>



<子宮>



34

不妊症の一般検査

9. 経膈超音波断層法

卵胞期初期

<卵巣>



<子宮>



35

不妊症の一般検査

9. 経膈超音波断層法

卵胞期中期

<卵巣>



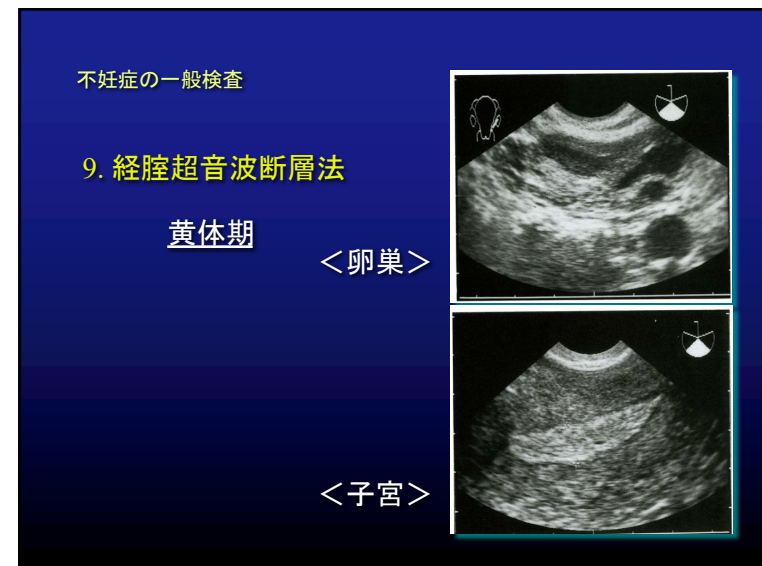
<子宮>



36



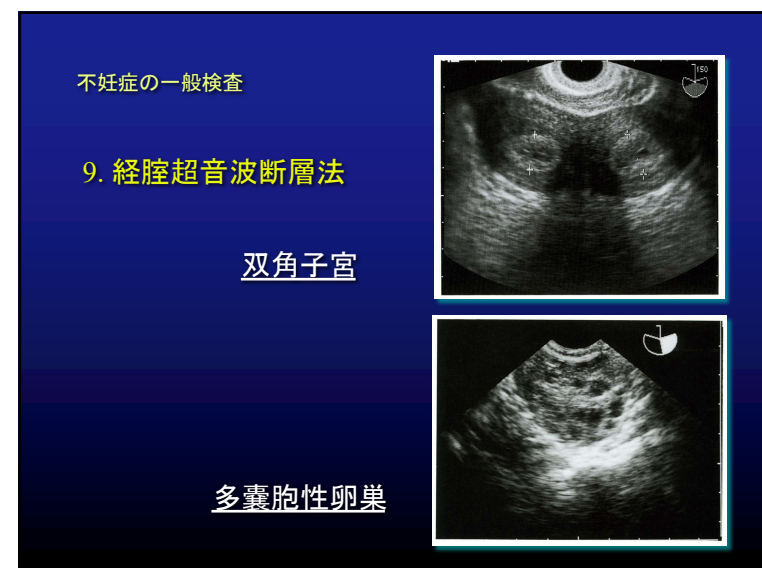
37



38



39

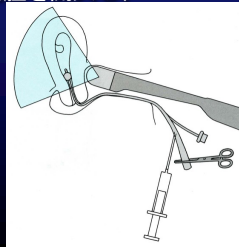


40

sonohysterography

<方法>

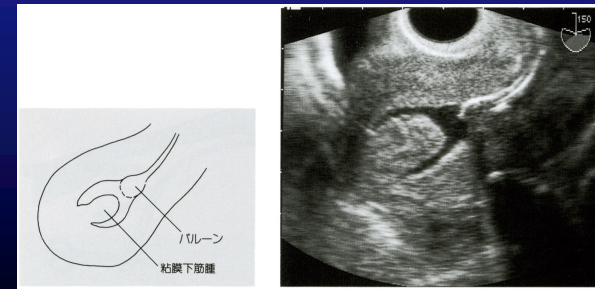
- 通常の超音波検査等で子宮内腔病変が疑われた際の二次検査として行う
- 子宮内に生理食塩水を注入して子宮内腔を開大し、経腔超音波にて子宮内腔を観察
 - ▶ 子宮内腔突出病変あるいは内膜画像を精密にとらえる上で非常に有用



41

sonohysterography

粘膜下筋腫



42

女性不妊症の治療

女性不妊症に対する主な治療法

1. 一般不妊治療

- a. 排卵誘発：内服、注射
- b. タイミング指導
- c. 人工授精

2. 生殖補助医療

体外受精・顕微授精等

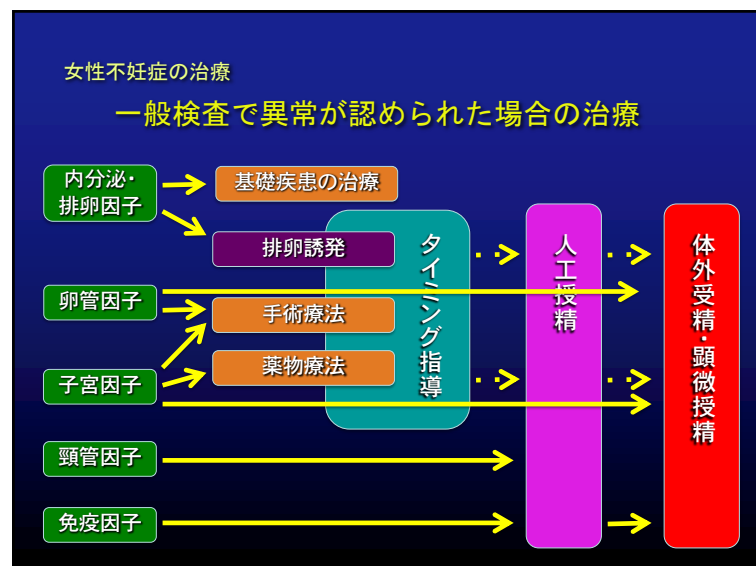
43

女性不妊症の治療

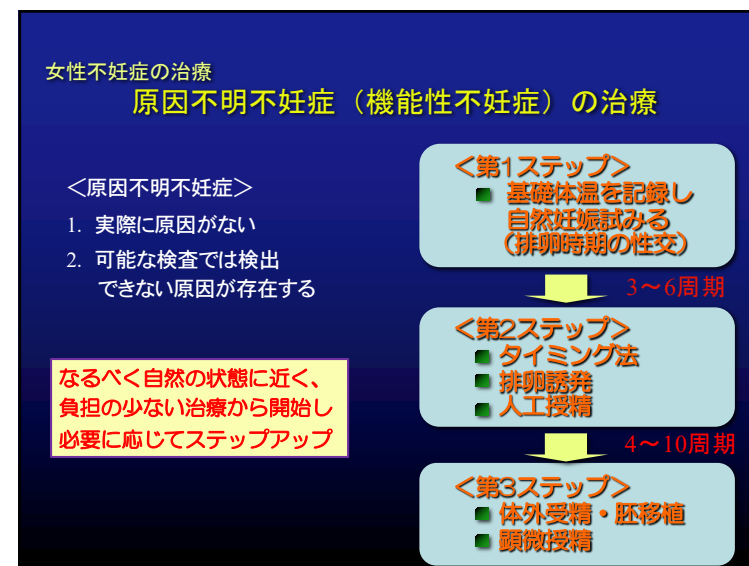
一般検査で異常が認められた場合の治療

1. 内分泌・排卵因子
 - a. 基礎疾患の治療
 - b. 排卵障害：排卵誘発
 - c. 黄体機能不全：排卵誘発、黄体賦活、黄体ホルモン補充
2. 卵管因子
 - a. 手術療法：癒着剥離、卵管形成
 - b. IVF-ET
3. 子宮因子
 - a. 子宮筋腫：待機療法、薬物療法、手術療法
 - b. 子宮内膜症：待機療法、薬物療法、手術療法、AIH、IVF-ET
 - c. 子宮奇形：待機療法、手術療法
4. 頸管因子 (Huhner test不良)：AIH
5. 免疫因子 (抗精子抗体陽性例)：AIH、IVF-ET

44



45



46

女性不妊症の治療

排卵誘発

1. クエン酸クロミフェン療法

視床下部レベルで内因性エストロゲンと競合的にレセプターと結合する。この結合物は、核内へ移送されないため、エストロゲンの低下と認識され、視床下部からのGnRHの分泌が高まり下垂体のFSH、LHが放出され卵胞の発育、成熟が促進される。

適応

- 内因性エストロゲンの分泌がある程度保たれている第一度無月経
- 視床下部障害による無排卵周期症（下垂体機能は保たれている）
- 多嚢胞性卵巣症候群

長所

- 排卵時期の一定化
- 排卵卵子数の増加

短所

- 抗エストロゲン作用：子宮内膜発育抑制、頸管粘液の減少等
- 卵巣過剰刺激：多胎、卵巣過剰刺激症候群

47

女性不妊症の治療

排卵誘発

2. レトロゾール療法

卵巣でのテストステロンからエストロゲンへの変換を触媒する酵素であるアロマターゼを阻害することでエストロゲン濃度を低下させ、下垂体からのFSHの分泌を促進し、卵胞発育を促す。また、卵巣中にテストステロンが蓄積することでFSH受容体の発現が増加することを介しても、卵胞発育を促す。

適応

- 内因性エストロゲンの分泌がある程度保たれている第一度無月経
- 視床下部障害による無排卵周期症（下垂体機能は保たれている）
- 多嚢胞性卵巣症候群

長所

- 卵巣刺激の程度が強くない
- 排卵卵子数の増加
- 抗エストロゲン作用が弱い

短所

- 卵巣過剰刺激：多胎、卵巣過剰刺激症候群

48

女性不妊症の治療

排卵誘発

3. ゴナドトロピン療法

FSH作用を持つhMG製剤あるいはFSH製剤を投与して卵胞の発育を促し、卵胞が成熟したら、LH作用のあるhCGを投与して排卵を誘起させる

適応

- 血中ゴナドトロピン値が低値を示す第2度無月経
- 血中ゴナドトロピン値が正常または軽度低下を示す第1度無月経、希発月経、無排卵周期症でCC無効例

長所

- 卵胞発育作用、排卵誘発作用が強い

短所

- 卵巣過剰刺激：多胎、卵巣過剰刺激症候群
- 流産率が高い

49

女性不妊症の治療

タイミング指導 (timed intercourse)

卵胞径、子宮内膜厚、頸管粘液の性状、尿中LH濃度、基礎体温より排卵時期を推定し、性交を行う

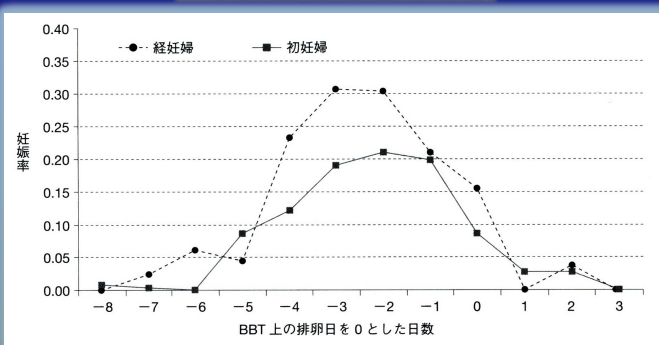
- 配偶子の生存期間に注意
 - 卵子：排卵後8時間～12時間
 - 精子：射精後2～3日

50

女性不妊症の治療

タイミング指導 (timed intercourse)

性交のタイミングと妊娠率

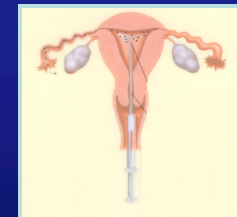


排卵日当日より、1-3日前の方が妊娠に至りやすい

51

女性不妊症の治療

人工授精 artificial insemination; AI



配偶者間人工授精

artificial insemination with husband's semen ; AIH

非配偶者間人工授精

artificial insemination with donor's semen ; AID

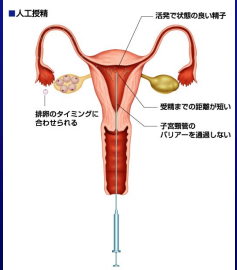
52

女性不妊症の治療

配偶者間人工授精

artificial insemination with husband's semen ; AIH

適 応



1. 精子・精液の量的・質的異常
乏精液症、乏精子症、精子無力症
2. 射精障害・性交障害
逆行性射精、勃起不全、重度尿道下裂
腔狭窄
3. 精子-頸管粘液不適合 (Huhner test 不良)
4. 抗精子抗体保有例 (軽症)
5. 機能性不妊

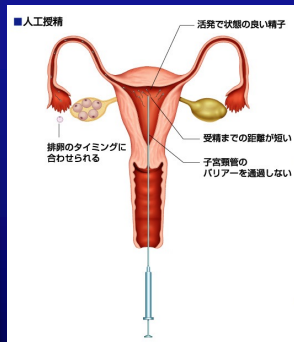
53

女性不妊症の治療

配偶者間人工授精

artificial insemination with husband's semen ; AIH

実施方法



1. 実施日は排卵日を目標
卵胞径、子宮内膜厚、
頸管粘液の性状、尿中LH測定、
基礎体温表より推定
2. 精液の調整
3. 精液注入 (0.3~0.5ml)
4. 臥床安静 (15~30分間)

治療周期あたりの妊娠率: 5~10%

54

女性不妊症の治療

配偶者間人工授精

artificial insemination with husband's semen ; AIH

合併症

1. 出血: 子宮頸管、子宮内膜の損傷
2. 疼痛: 子宮攣縮、腹膜刺激
3. 感染

55

女性不妊症の治療

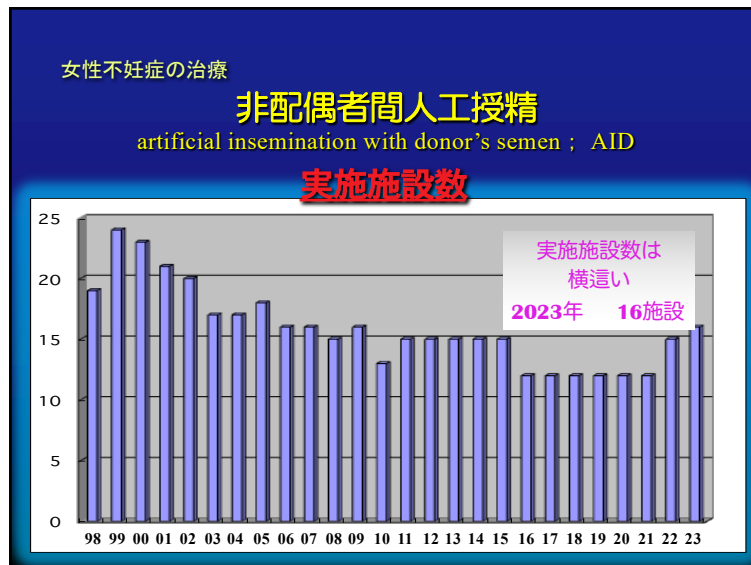
非配偶者間人工授精

artificial insemination with donor's semen ; AID

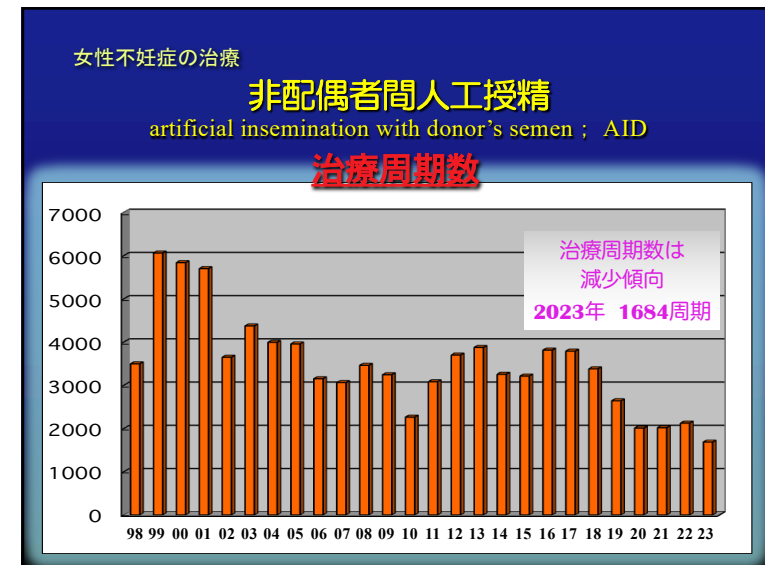
適 応

1. 女性側要件
明らかな不妊原因が認められないか、
もしくは治療可能
2. 男性側要件
無精子症 azoospermia
無精液症 aspermia
精子死滅症 necrozoospermia

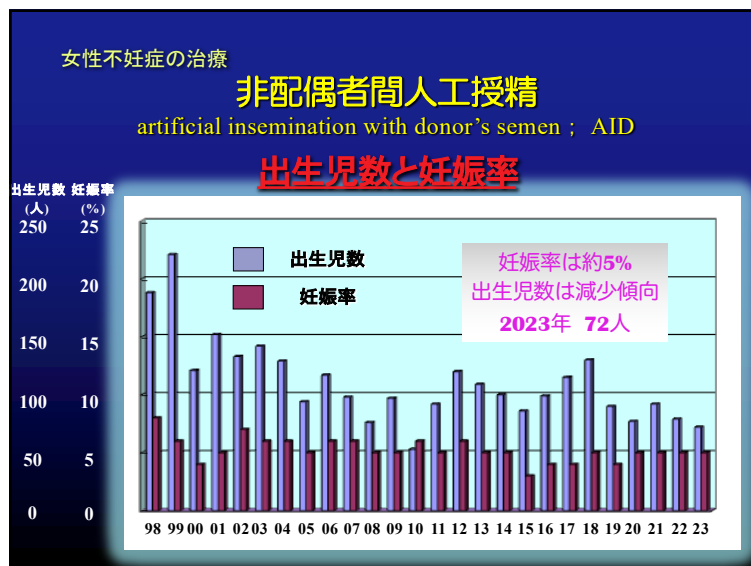
56



57



58



59

女性不妊症の治療

生殖補助医療（技術）
assisted reproductive technology (ART)とは？

「妊娠成立を目的として行なう処置のうち、
ヒトの卵子と精子の両方、または胚への
体外での操作を伴う全ての治療や手技のこと。」

(日本産科婦人科学会「ARTに関する用語集」)

60

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植

in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

「本法は、これ以外の治療によっては妊娠の可能性がないか極めて低いと判断されるもの、および本法を施行することが、被実施者またはその出生児に有益であると判断されるものを対象とする。」

(日本産科婦人科学会「体外受精・胚移植に関する見解」)

61

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植

in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

適 応

1. 卵管性不妊症
2. 男性不妊症
3. 免疫性不妊症
4. 原因不明不妊症（機能性不妊症）

62

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植

in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

治療の概要

1. 卵巣刺激(過排卵刺激)
2. 採卵
3. 精子の採取と調整
4. 受精(媒精)と胚培養
5. 胚移植
6. 黄体ホルモンの補充

63

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植

in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

卵巣刺激法の種類

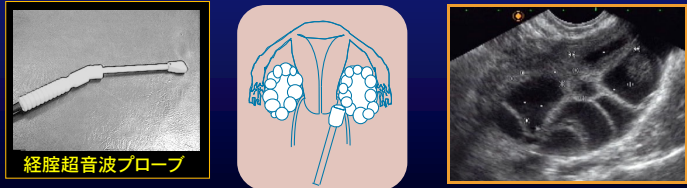
1. 自然周期
2. 内服:クエン酸クロミフェン、レトロゾール等
3. 注射:ゴナドトロピン製剤
 - GnRH agonist併用
 - GnRH antagonist併用
 - プロゲステン併用

64

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植
in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

卵胞発育のモニタリング



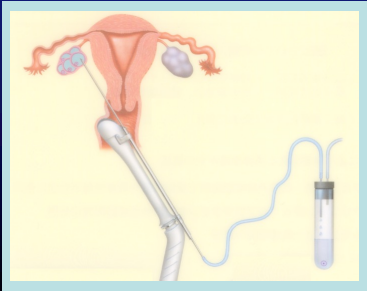
経膈超音波プローブ

65

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植
in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

採卵

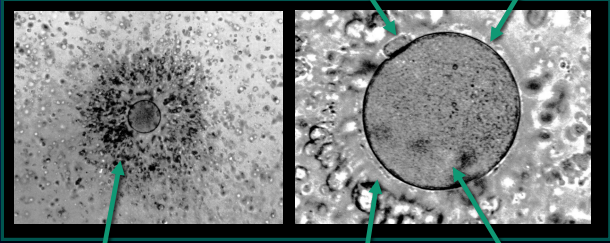


66

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植
in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

成熟卵子



1st Polar body
第一極体

Perivitelline space
囲卵腔

Corona radiata
放射状冠

Zona pellucida
透明帯

Ooplasm
卵細胞質

67

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植
in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

媒精（受精）と受精卵

媒精：卵子の存在する培養液内に精子を添加



2 Pronuclei (2PN) stage
2前核期胚

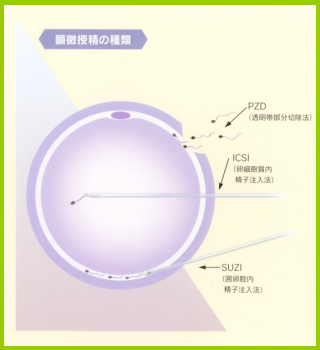
- 雌性前核
- 雄性前核

68

女性不妊症の治療

顕微授精

顕微授精の種類



1. 透明帯開口術
Partial Zona Dissection; PZD

2. 卵卵腔内精子注入法
Subzonal Sperm Injection; SUZI

3. 卵細胞質内精子注入法
Intracytoplasmic Sperm Injection; ICSI

69

女性不妊症の治療

卵細胞質内精子注入法 intracytoplasmic sperm injection; ICSI

適応



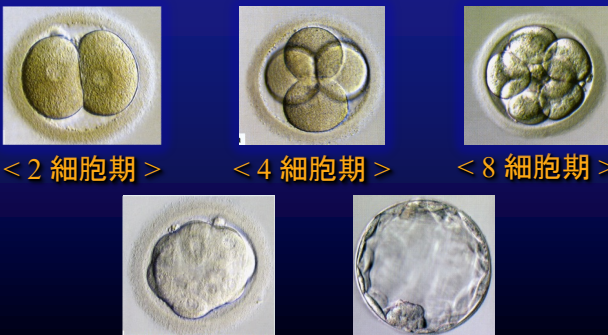
1. 男性因子例
重度乏精子症、精子無力症、精子奇形症およびその合併例
不動精子症例
精巣上体精子あるいは精巣精子による受精
2. 体外受精での受精障害例
精子-透明帯/卵細胞膜貫通障害
抗精子抗体陽性

70

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植 in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

胚の発生



< 2 細胞期 > < 4 細胞期 > < 8 細胞期 >

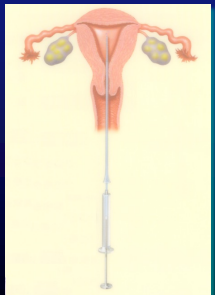
< 桑実胚期 > < 胚盤胞期 >

71

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植 in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

胚移植



- ▶ Day 2~5に2細胞～胚盤胞期の胚を子宮内に移植
- ▶ 移植する胚は原則1個⇐多胎の回避

72

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植

移植胚数に関連する会告等

- ▼ 1996年 (日本産科婦人科学会)：3個以下
- ▼ 2007年 (日本生殖医学会)：2個以下
- ▼ 2008年 (日本産科婦人科学会)：原則1個

「多胎妊娠」に関する見解改定について

日本産科婦人科学会（以下、本学会）は、生殖補助医療の普及にともない増加した多胎妊娠を防止する目的で、平成 8 年「多胎妊娠」に関する見解を発表し、会員に遵守を求めました。その後、生殖補助医療の技術はさらにめざましい進歩を遂げ、治療成績と安全性の向上を果しています。一方、周産期医療の場を転じると、母体および新生児の管理を担う体制は、施設、医療者とも、その量において相対的にきわめて不十分な状況となっています。これには、多胎妊娠の増加にともない、管理を要する母体と出生する早産児が増加したことも、その要因として大きく関与していると考えられます。ここに本学会は、母体および胎児・新生児の健全なる福祉を保持する観点から、生殖補助医療にとりもって発生する多胎妊娠をさらに減少せしめることが急務と考え、現在の生殖補助医療技術の水準を基に、次のとおり見解を改定いたします。

生殖補助医療における多胎妊娠防止に関する見解

生殖補助医療の胚移植において、移植する胚は原則として単一とする。ただし、35歳以上の女性、または2回以上続けて妊娠不成立であった女性などについては、2胚移植を許容する。治療を受ける夫婦に対しては、移植しない胚を後の治療周期で利用するために凍結保存する技術のあることを、必ず提示しなければならぬ。

平成 20 年 4 月 12 日

社団法人 日本産科婦人科学会
理事長 吉村 泰典
倫理委員会委員長 長谷 晃

73

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植

in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

生殖補助医療における移植胚数制限と多胎率

移植胚数の制限により多胎率低下

1998年：18%
↓
2004年：15%
↓
2010年：5%
↓
2021年：3%

(日本産科婦人科学会 ARTデータブック)

74

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植; IVF-ET

胚の凍結保存

目的

- 採卵周期で妊娠成立しなかった場合、後の周期で融解胚移植する
 - 繰り返す卵巣刺激や採卵による負担軽減
- 新鮮胚移植が不適当な場合、すべての胚を保存
 - 卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)
 - 子宮内膜状態不良：肥厚、菲薄

75

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植

in vitro fertilization and embryo transfer; IVF-ET

問題点

- 経腔採卵に伴う外科的合併症
大血管の損傷、腸管損傷、骨盤内感染症
- 卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)
- 多胎妊娠

76

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植 ; IVF-ET

卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)

- 原因: 排卵誘発剤による過排卵刺激
特にゴナドトロピン注射 (FSH/hMG+hCG)
- 病態: 卵巣腫大、腹水・胸水貯留、血液濃縮など
- 症状: 腹部膨満感、腹痛、体重増加、乏尿など
▶ 重症化例→肝障害、腎障害、血栓症、呼吸障害、
多臓器不全、卵巣茎捻転
- リスクファクター: 若年者 やせ形体型 PCOS
エストラジオールの上昇
hCGによる黄体賦活 妊娠成立

77

女性不妊症の治療

体外受精・胚移植 ; IVF-ET

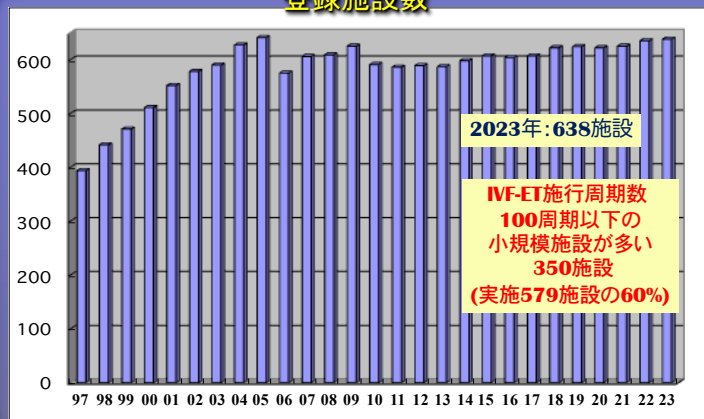
卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)

- 治療法
 - 安静
 - 点滴治療: 血液濃縮改善、尿量の確保、
電解質バランスの是正、低蛋白改善
- 予防法
 - 卵巣刺激法の工夫 (hCG注射キャンセルなど)
 - 体外受精治療における胚移植回避
 - カベルゴリン内服による発症抑制

78

女性不妊症の治療

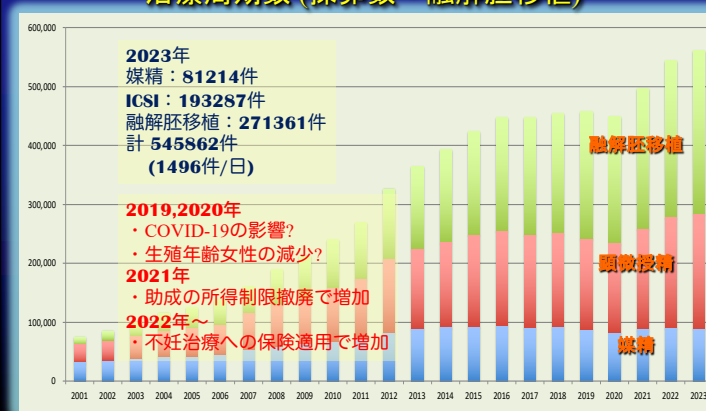
体外受精・胚移植
登録施設数



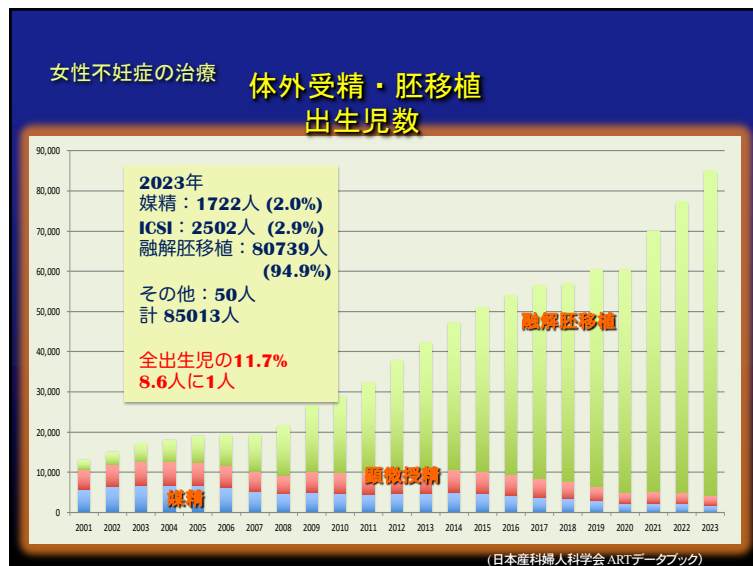
79

女性不妊症の治療

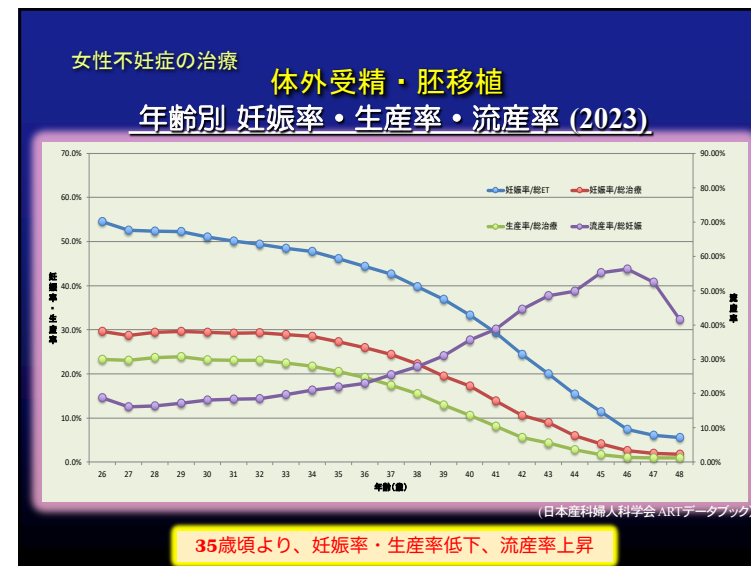
体外受精・胚移植
治療周期数 (採卵数・融解胚移植)



80



81



82

女性不妊症の治療

不妊治療の特殊性

- 不妊であること自体は日常生活に支障を来すような症状ではない
- 必ずしも治療の成果が得られるとは限らない
- 周囲の人々からのプレッシャーがある
- 年齢的な期限がある
- 身体的、経済的、精神的負担がある

83